



异食癖

作者: [Evelyn Attia](#), MD, Columbia University Medical Center;
[B. Timothy Walsh](#), MD, College of Physicians and Surgeons, Columbia University
Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry
已审核/已修订 8月 2025 | 修改的 9月 2025

异食癖是一种进食障碍，特征是经常食用一些非食物的东西。

- 通常，异食癖患者吃的东西不会对他们造成伤害，但有时他们进食的东西会引起并发症，如消化道梗阻或铅中毒。
- 当年龄超过 2 岁的人进食非食物的东西达一个月或以上时，医生通常会诊断异食癖。
- 行为矫正疗法可能有帮助，但目前尚无专门针对异食癖的治疗方法。
- 营养不良和其他并发症可按需治疗。

异食癖者经常吃一些不能吃的东西（如纸、陶土、泥土或头发）。由于原因尚不明确，异食癖也可能发生在妊娠期及缺铁性贫血患者身上。此行为如果发生在 2 岁以下儿童，则视为正常发育现象。幼儿常将非食物物品放入口中，有时还会吞食。

在世界某些地区，进食不属于食物的东西是传统文化（如民间医药、宗教仪式或惯常做法等）的一部分。例如，佐治亚州皮德蒙特地区的有些人定期吃陶土，这是他们文化传统的一部分。

通常而言，异食癖者所吃的东西不会对其造成伤害。但是，他们吃的东西有时会导致并发症，例如[缺铁](#)和[缺锌](#)、[便秘](#)、[消化道阻塞](#)、[铅中毒](#)（因吞食油漆碎屑）或[寄生虫感染](#)（因吞食泥土）。

异食癖本身很少影响社会功能，但它常常合并其他精神疾病，这些疾病可影响社会功能。这些疾病包括[孤独症](#)、[智障](#)和[精神分裂症](#)。吞咽异物以自残或伪造疾病（如人为性障碍所表现）的行为不被视为异食癖。

异食癖的诊断

- 医生根据标准精神病标准进行评估
- 各项辅助检查，以排查可能的并发症

通常，医生通过判定患者在吃什么东西来诊断异食癖。

患者持续吃一些不属于食物的东西，持续 1 个月或更长时间，即可诊断为异食癖。两岁以下的儿童出现这种行为不诊断为异食癖，因为在那个年龄时，吃这些东西不会被认为是异常的。如果异食行为是文化的一部分，也

不诊断为异食癖。

如果医生怀疑本病，他们会评估患者的[营养状况](#)，确认是否存在体重减轻和营养不良。

有些时候，异食癖是在儿童出现消化道梗阻症状（比如重度痉挛或便秘）或铅中毒并被带到急诊科或门诊就诊时确诊的。

要确认消化道梗阻，可能需要做 X 线检查。

医生可能会做血液检查，以检查铅中毒或寄生虫感染。

异食癖的治疗

- 有时需采取行为矫正治疗
- 治疗营养不良和其他并发症

行为矫正疗法可能有帮助，但目前尚无专门针对本病的治疗方法。行为矫正疗法可帮助人们消除不理想的行为，同时学习更好的行为。

对营养不良和其他并发症进行治疗。消化道梗阻可能需要手术。

异食癖可在持续数月后自行消失，特别是在儿童中。

了解更多信息

以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[美国进食障碍帮助协会 \(NEDA\)](#)

[美国国家神经性厌食症和相关疾病协会 \(ANAD\)](#)